

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

LARINGITIS AGUDAS

J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.

Infecciosas

Introducción:

Causa más frecuente de disfonía aguda. En edad pediátrica cuadros de laringotraqueítis/crup laríngeo con mayor afectación subglótico. De predominio en invierno. Puede aparecer tras esfuerzo o abuso vocal importante.

Agente implicado: virus respiratorios (adenovirus, myxovirus). Algunas entidades con microorganismos específicos (mycoplasma, difteria, TBC, hongos,...)

Clínica: disfonía acompañada de odinofagia, tos y febrícula.

Exploración: no adenopatías cervicales. Faringoscopia poco llamativa.

Laringoscopia indirecta/ fibrolaringoscopia: eritema de ambas cuerdas vocales.

Diagnóstico

Clínico

Tratamiento En Urgencias

- Reposo vocal
- Gargarismos
- Abundante hidratación
- Ambiente húmedo y aerosoles.
- Antiinflamatorio habitual (Ibuprofeno 600 mg/8 h o Dexketoprofeno 25 mg/8h durante 4-5 días)
- Ciclo corto de corticoides orales (prednisona)

No Infecciosas

Introducción

Existen diferentes tipos (alérgicas, térmicas, traumáticas, por reflujo y por cáusticos). Vigilar los inhalantes en pacientes con patología pulmonar.

Clínica: disfonía. Picor faringolaríngeo. Carraspera.

Exploración: irritación laríngea.

Diagnóstico

Sospecha clínica

Tratamiento

Medidas higiénicas, reposo vocal, hidratación. Con sospecha de signos indirecto de ERGE, pautar IBP (Omeprazol 20 mg/24 horas 6 semanas).

Nota

- Ante una disfonía de más de 3 semanas de evolución. Derivar a consultas externas de ORL

Bibliografía

- Shah K, Stanley Shapshay R, "Acute laryngitis" Emedicine; Web MD, 2006
- Libro Virtual de Formación en Otorrinolaringología de la Sociedad Española de

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Capítulo 102.Madrid. 2015.